

Información General			
PSP / CRS(Producto)* NEXAVAR 200MGX60C(12000MG)INST		País* Colombia	Ciudad* IPIALES
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-05-24	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP15000 Nombre Completo MARIA JULIA MONTENEGRO PORTILLA	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1954-06-06	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: CARLOS JOSE NARVAEZ	
		Teléfono: 322 2014101	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. SORAFENIB /NEXAVAR	2. SORAFENIB /NEXAVAR	3. SORAFENIB /NEXAVAR
Indicación	CARCINOMA DE TIROIDES DIFERENCIADO, AVANZADO REFRACTARIO A YODO RADIOACTIVO	CARCINOMA DE TIROIDES DIFERENCIADO, AVANZADO REFRACTARIO A YODO RADIOACTIVO	CARCINOMA DE TIROIDES DIFERENC
Formulación	800 MG	800 MG	800 MG
Régimen de dosis	400 MG (2 COMPRIMIDOS DE 200 MG) DOS VECES AL DIA	400 MG (2 COMPRIMIDOS DE 200 MG) DOS VECES AL DIA	400 MG (2 COMPRIMIDOS DE 200 MG) DOS VECES AL DIA
Ruta de administración	ORAL	ORAL	ORAL

Número de lote *	N/A	N/A	N/A
Fecha de expiración			
Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2018-03-06	2018-03-06	2018-03-26
Tratamiento continuó? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	SI Si es No, fecha de suspensión:	SI Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. AE	2. AE	3. AE
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	SI	SI	SI
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO	NO	NO
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)	2018-03-20	2018-03-20	2018-03-26
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	recuperado Fecha de recuperación Fecha de la muerte	recuperandose Fecha de recuperación Fecha de la muerte	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	La paciente comenta que a las dos semanas de haber comenzado a tomar el tratamiento presentÃ³ un brote que se caracterizo por manchas de color cafes en todo el cuerpo, que no causaban dolor ni tampoco rasquiÃ±a acompaÃ±ado de hinchazÃ³n de las orejas con descamaciÃ³n, las cuales fueron desapareciendo cuando el oncÃ³logo decidio bajar la dosis a tomar un comprimido de 200 mg dos veces al dÃ­a (400 mg diarios). En la actualidad no tiene brote ni tampoco presenta hinchazon de orejas ni descamaciÃ³n	La paciente comenta que a las dos semanas de haber comenzado a tomar el tratamiento presentÃ³ hinchazÃ³n de la lengua acompaÃ±ado de dolor. Tanto la hinchazÃ³n como el dolor fueron desapareciendo cuando el oncÃ³logo decidio bajar la dosis a tomar un comprimido de 200 mg dos veces al dÃ­a (400 mg diarios). En la actualidad no tiene hinchazÃ³n de la lengua. El dolor es leve y casi permanente	La paciente comenta que a las dos semanas de haber comenzado a tomar el tratamiento presentÃ³ un brote que se caracterizo por manchas de color cafes en todo el cuerpo, acompaÃ±ado de hinchazon de las orejas con descamacion y tambien hinchazon de la lengua con dolor, por lo que acudiÃ³ al oncologo tratante el dia 26 de marzo y le comento sobre esta situacion y el oncÃ³logo decidio bajar la dosis de 800 mg diarios a 400 mg diarios y le ordenÃ³ tomar un comprimido de 200 mg dos veces al dÃ­a. La paciente toma esta dosis hasta la actualidad.
Informaci3n adicional (antecedentes m3dicos, explicaci3n alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

EL PACIENTE TAMBIEN TIENE TRATAMIENTO DE ACIDO IBANDRONICO. EL PACIENTE EN EL MOMENTO DEL CONTACTO NO CUENTA CON LA CAJA DONDE VINIERON LOS BLISTER DEL MEDICAMENTO POR LO QUE NO SE PUEDE TOMAR EL NUMERO DE LOTE NI DE FECHA DE EXPIRACION Y TAMPOCO TIENE EL BLISTER A LA MANO.

Información del Reportante (Staff PSP)*

Nombre:	LMIRANDA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Teléfono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com